جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : الهام سعيد محمد ابراهيم
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الهرم **العنوان :** ---
رقم البطاقة : 27303141301262 **رقم التليفون :** 01144486362 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 09-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-03-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: الهام سعيد محمد ابراهيم
National ID: 27303141301262

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



الهام
سعيد محمد ابراهيم
٥ تقسيم الصيفى-ش سعد زغلول
الهرم - الجيزه

٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٦٢

KP8286078

٢٠٢٤/٠٦

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
مجدى عبدالحميد محمد حسين

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٦/٢٥

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]



انهام
سعيد محمد ابراهيم
د تقسيم التصفيش سعد زغلول
الهرم - الجيزه

٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٦٢

KP8286078



٢٠٢١/٠٦ ٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٦٢

ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة
مجدى عبدالحميد محمد حسن
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٦/٢٥



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6728

	Female	النوع	
	القاهرة	العنوان	45 Y
	29/11/2018 12:28	تاريخ استلام العينة	
	06/12/2018 11:15	تاريخ التقرير	

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER &PR & HER2 neu (ER&RP : Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (1E2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using [illegible] kit in ventana benchmark GX.

Result :

ER:weak nuclear staining of 80 % of tumour cells
PR: NO nuclear staining of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells

Referal Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 6/8)
PR: NEGATIVE
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

Pathologist: [illegible]

Lab Director [illegible]

19 El-sheikh Rohan Sueet, Abeideen, Cairo
Tel (165)7948544 -7950096 Fax (202)7948544
Mobile . 01144297292
website http://www.healthlabs.net
email pathologychl@yahoo.com
facebook: [illegible]

This Test Is Not Accredited By [illegible]

ImmunohistoChemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Pathology Report

Name: [redacted] Age: 45 years.

Clinical data: History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes.

Specimen Type: Left axillary clearance.

Date: 6/11/2018

Lab. Number: 682 Hospital Number: 2611/2018

Gross Description:

Axillary tissue 9x8 cm entangling 9 nodules, the largest 2.3x2 cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed lymph nodes, two of them showed deposits of atypical round epithelioid cells, likely ductal mammary cells.

Diagnosis:

History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes, Left axillary clearance:

- Metastatic deposits of carcinoma in (2/9) lymph nodes.
- Likely of ductal origin.

Prof. Dr. Amr El-Sabea.

Dr. Inas Mohamed Ali.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Pathology Report

Name: [illegible] Age: 45 years.

Clinical data: History of right breast cancer with left suspicious lymph n.

Specimen Type: Left axillary clearance.

Date: 6/11/2016

Lab. Number: 682 Hospital Number: 2614/2016

Gross Description:

Axillary tissue 9x8 cm entangling 9 nodules, the largest 2.3x2 c.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed lymph nodes, two of them showe. of atypical round epithelioid cells, likely ductal mammary cells.

Diagnosis:

History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes. Left axilla[illegible]

- Metastatic deposits of carcinoma in (2/9) lymph nodes.
- Likely of ductal origin.

Prof. Dr. Amr El-Sabea.

Dr. Inas Mohamed Ali.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: WILLIAM SAEED

Date: 06/02/2020

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Diffuse Parenchymal distortion of right breast with overlying skin thickening.
- Ill defined pleural based consolidative patch with surrounding reticular infiltrates are seen at right middle lobe.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. Mild pericardial effusion is detected.
- Left port-a-cath is noted.
- Normal appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- *Diffuse Parenchymal distortion of right breast with overlying skin thickening.*
- *Right middle lobe ill defined pleural based consolidative patch with surrounding reticular infiltrates likely inflammatory for clinical correlation & follow up.*
- *Mild pericardial effusion.*

DR. Ibrahim Elsedawy.M.Sc

Dr.m.gomaa,md

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

...ation for Teaching Hospitals
and Institutes
Ahmad Maher Teaching Hospital

...ient Name	...	Date	1/10/2018

ABDOMEN AND PELVIS ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION REVEALED:-

Liver: Average size (15 cm at RT MCL) with bright homogenous hepatic parenchymal echopattern and smooth surface contour. No focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation. Portal vein is not dilated

Gallbladder: Average distention with no evidence of stones, masses or mud inside. Average wall thickness. CBD is not dilated

Spleen: Average size (9.6 cm in long axis) with homogenous parenchymal echopattern. No focal lesion. Splenic vein is not dilated.

Pancreas and para-aortic region: Concealed by gases.

Kidneys: Both are of average size, normal position and shape, average parenchymal thickness and echogenicity with good corticomedullary differentiation. No stones or back pressure changes. No focal cystic or solid mass lesions.

Urinary bladder: Average distension with normal wall thickness. No stones, masses or diverticular out pouching.

Uterus: Anteverted flexed uterus with average size and normal homogeneous myometrium, measures about 8 X 5 X 3 cm. Average endometrial thickness with normal echopattern, measures about 9 mm. No uterine masses or content seen.

***Both ovaries and adnexa: Left ovary showing a cyst measuring about (3.5x3.7cm) showing internal septations,no soft tissue componant,no internal vascularity.** Right ovary is Average size with normal shape and echogenicity of both ovaries. No cystic or solid adnexal mass lesions.*

No abdominal or pelvic collections. No gross mass lesions seen.

Opinion::

- ***Bright likely fatty liver for LAB correlation***
- ***Left ovarian complicated cyst for follow up.***

Best Regards

Dr. Enass Hamdy MS.

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: Elham Saeid Mohamed | Date: 9 October 2021

ABDOMINAL AND PELVIC ULTRASONOGRAPHY REPORT

- Liver: is mild enlarged in size displaying homogenous bright echopattern with no definite focal lesions or intrahepatic biliary radicles dilatation.
- PV: is patent & of normal caliber with hepato-petal flow.
- Gall Bladder: is partially distended harboring few stones sizes below 5-9 mm.
- CBD: is of average caliber containing no stones
- Spleen: is average in size displaying homogenous echopattern with no focal lesions.
- Both kidneys: are of average site, size, shape with average cortico-medullary differentiation & normal parenchymal echogenicity. They contain no significant back pressure changes and no sizable stones.
- Pancreas & para-aortic area: gas obscured
- Urinary bladder: is of average distension regular non thickened walls showing no stones, masses or diverticular outpouchings.
- Pelvis/Both adnexa show no solid or cystic pathologies
- No pelvi-abdominal free fluid.

CONCLUSION

- Mild fatty hepatomegaly.
- Calcular gall bladder.
- Moderate bowel gaseous distension.

Ds. Sharif Mostafa, M. Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name: Ekram Saad

Date: 10-10-2021

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

- Patient had right CBS.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular densities (ACR B)
- Post-operative changes of the right breast in terms of
  - ✓ UOQ operative bed scarring with related focal area of parenchymal distortion.
  - ✓ diffuse skin thickening reaching (7 mm)
  - ✓ No gross suspicious operative bed masses
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Normal skin thickness and nipple areola complex, with average caliber of the retro areolar ducts of the left breast.
- No pathological axillary lns
- Free right infra and supra clavicular regions

Opinion:

- Post right CBS showing operative bed changes with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Dr. Peter Fahmy

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]